



4.3. Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos (Structured Interview for Prodromal States, SIPS)

1

SIPS

ENTREVISTA ESTRUCTURADA PARA SÍNDROMES PRODRÓMICOS (idioma español)

VERSIÓN PARA SÍNDROMES PRODRÓMICOS ACTUALES

PRIME Clínica de Investigación
Escuela de Medicina de Yale
New Haven, CT

Thomas H. McGlashan, M.D.
Tandy J. Miller, Ph.D.
Scott W. Woods, M.D.
Joanna L. Rosen, Psy.D.
Ralph E. Hoffman, M.D.
Larry Davidson, Ph.D.

París, 3 de marzo, 2002 – Versión en español 3.1

Julio Bobes*, Celso Arango**, Teresa Bobes-Bascarán,
M.^a Teresa Bascarán* y Mara Perellada**

Copyright ©2001 Thomas H. McGlashan, M.D

*Universidad de Oviedo. **Hospital Gregorio Marañón, Madrid.

Instrucciones para el evaluador

Los objetivos de la entrevista son:

- I. Descartar psicosis pasadas y actuales.
 - II. Identificar uno o más de los tres tipos de estados prodrómicos.
 - III. Evaluar la gravedad de los síntomas prodrómicos.
- I. Psicosis pasada. Si las psicosis anteriores no han sido excluidas con una investigación inicial, ésta se menciona aquí por medio del Resumen y la historia Demográfica (pág. 159).
 - II. Psicosis actual. La psicosis sólo se define por síntomas positivos. Descartar la psicosis actual requiere preguntar y medir al paciente con cinco aspectos fiables del síntoma: contenido del pensamiento inusual/delirante, suspicacia, grandiosidad, percepciones anormales/alucinaciones y expresión desorganizada.

El *síndrome psicótico* se define como:

Se requieren los criterios A y B.

- (A) Síntomas positivos en un nivel de intensidad psicótico (puntuado como 6)
 - Contenido del pensamiento inusual, suspicacia/persecución, o grandiosidad con ideas delirantes
y/o
 - Percepción anormal con alucinaciones
y/o
 - Lenguaje ininteligible
- (B) Cualquier síntoma del criterio A con una frecuencia o duración suficiente o urgencia:
 - Al menos un síntoma de A ha estado presente al menos una hora al día y al menos 4 días por semana durante un mes
o
 - El síntoma indica desorganización o peligro.

Estos síntomas se evalúan por la Escala de Síntomas Prodrómicos (SOPS), específicamente por las escalas P1-P5. La SOPS mide principalmente el grado de la intensidad de los síntomas no psicóticos. Sin embargo, una puntuación de 6 en la SOPS (grave y psicótico) es semejante al ya mencionado criterio A. Sin embargo, tanto si está presente el *síndrome psicótico* como si no, también depende de la frecuencia o la intensidad del/de los síntoma/s del criterio A. Si se cumple el criterio B, se define por lo tanto el *síndrome psicótico*.

- III. A los pacientes que no cumplen un criterio de *síndrome psicótico* se les evalúa para averiguar si se hallan en uno o más de los tres *síndromes prodrómicos*. Éstos son los Criterios de los *síndromes Prodrómicos* (COPS) y están detallados a continuación. El primer grupo prodrómico (A) presenta claramente síntomas psicóticos que son recientes y muy breves. El segundo grupo prodrómico (B) presenta síntomas atenuados psicóticos recientes de frecuencia y/o gravedad suficiente. El tercer grupo prodrómico (C) combina riesgo genético y deterioro reciente de funcionamiento global.

En la sección de «Preguntas» de cada ítem, pregunte cada cuestión numerada. Las preguntas que no están en negrita son opcionales y son propuestas para ayudar a clarificar y elaborar respuestas seguras.

Los «síntomas prodrómicos» se describen y evalúan usando la SOPS (Escala de Síntomas Prodrómicos). La SOPS tiene dos escalas, una para evaluar síntomas positivos y otra para síntomas negativos/de desorganización/generales.

La evaluación de los síntomas positivos en la SOPS oscila de 0 (ausente) a 6 (grave y psicótico).

SOPS para síntomas positivos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
---------------------	------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Los síntomas negativos/de desorganización/generales que se evalúan por la SOPS oscilan de 0 (ausente) a 6 (extremo).

SOPS para síntomas negativos/de desorganización/generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
---------------------	------------------------------	------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

Especificaciones: Para cada respuesta positiva a una pregunta, el entrevistador debe usar especificaciones para obtener más información detallada.

- Comienzo-Duración-Frecuencia.
- Grado de angustia: ¿cómo es esta experiencia para usted? (¿le molesta?).
- Grado en el que interfiere con la vida: ¿actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Ha hecho alguna vez algo diferente debido a esta experiencia?
- Grado de convicción/significación: ¿cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto podría estar sólo en su cabeza? ¿Piensa que esto es real?

CRITERIOS DE SÍNDROMES PRODRÓMICOS

A. Síndrome psicótico breve intermitente

La psicosis puede descartarse (paso I) aunque estén presentes síntomas positivos psicóticos (SOPS puntúa = 6) si no implican desorganización o peligro o no duran al menos una hora al día, cuatro días por semana durante un mes. Si los síntomas de intensidad psicótica no han estado nunca presentes con esa frecuencia, pero han empezado en los tres meses anteriores y están actualmente presentes al menos varios minutos al día con una frecuencia de al menos una vez al mes, se cumplen los criterios para este síndrome prodrómico.

B. Síndrome con síntomas positivos atenuados

Los síntomas prodrómicos positivos atenuados se encuentran en las escalas P1-P5 de la SOPS. Una puntuación ≥ 3 (gravedad moderada) en cualquier escala sintomática define el nivel prodrómico de intensidad. Si el síntoma ha empezado o ha empeorado más de un punto, comparado con la puntuación de hace 12 meses y aparece al menos una vez a la semana en el mes anterior, se reúnen los criterios para este síndrome prodrómico.

C. Síndrome de riesgo genético y disfunción global

El síndrome prodrómico final consiste en una combinación de riesgo genético de un trastorno del espectro esquizofrénico y de deterioro funcional global reciente. Los criterios del riesgo genético se reúnen cuando el paciente tiene un pariente de primer grado con algún trastorno psicótico (afectivo o no afectivo) y/o el paciente cumple los criterios de DSM-IV del trastorno de personalidad esquizotípico. El deterioro funcional se define operacionalmente como la disminución en la GAF de un 30 % o más durante el último mes en comparación con la puntuación de hace 12 meses.

Los síndromes prodrómicos A, B y C no se excluyen mutuamente. Los pacientes pueden reunir criterios de 1, 2 o los 3 tipos de síndrome.

IV. Los pacientes que cumplen los criterios de al menos uno de los síndromes prodrómicos son evaluados con el resto de la escala de valoración SOPS para síntomas negativos, síntomas de desorganización y síntomas generales. El objetivo aquí es el de conseguir la mayor descripción/valoración de la diversidad de síntomas prodrómicos. Las puntuaciones conseguidas aquí no definirán la pertenencia a las categorías prodrómicas pero proporcionarán una estimación cuantitativa de la gravedad de los síntomas prodrómicos.

Algunos investigadores pueden preferir obtener la SOPS completa en todos los pacientes.

Resumen e historia demográfica

Use bolígrafo de punta redonda, preferiblemente negro. No use lápiz.

Me gustaría empezar tomando unos minutos para preguntarle unas cuestiones acerca de usted y su familia.

1. ¿Cuál es su nombre completo? _____
2. ¿Cuál es su dirección actual? (Escriba su n.º de apartamento) _____
3. ¿Tiene teléfono? Si lo tiene, ¿cuál es su número de teléfono? [C] _____ [T] _____
4. Contacto alternativo: Nombre: _____ Número tel.: _____
5. ¿Cuál es su edad? _____ Fecha de nacimiento: _____
6. ¿Cuál es su sexo? [1] Hombre [2] Mujer
7. ¿Está actualmente en la escuela? [1] Sí [2] No Curso actual: _____
Nivel de estudios: _____
8. ¿Cuál es su estado civil? [1] Soltero [2] Casado [3] Divorciado [4] Vive con su pareja
9. ¿Cuáles son sus raíces étnicas? [1] Afroamericano/negro [2] Asioamericano/Islands del Pacífico
[3] Caucásico [4] Americano nativo [5] Otro, por favor especifique: _____
10. ¿Es latino o de otro origen hispano? [1] No [2] Sí
11. ¿Cuál es su religión o la de su familia? [1] Católica [2] Judía [3] Musulmana [4] Protestante
[5] Otra, por favor especifique: _____ [6] Sin religión
12. ¿Con quién vive? (Por favor, dé el número por cada tipo de relación enunciada y describa su situación familiar y tipo de vínculo [incluya los nombres y edades de sus parientes])
[1] Abuelos/padres _____
[2] Pareja/esposo _____
[3] Hijos _____
[4] Otro pariente _____
[5] Compañero/s de vivienda _____
[6] Solo _____
[7] Otros _____
13. ¿Cuál es la ocupación de su madre? _____ ¿Mayor nivel de estudios alcanzado? _____
14. ¿Cuál es la ocupación de su padre? _____ ¿Mayor nivel de estudios alcanzado? _____
15. ¿Está recibiendo tratamiento médico? Si sí, explique. Si es así, por favor déme el nombre/s y número/s de teléfono de su/s doctor(es):

16. ¿Está recibiendo tratamiento psiquiátrico? ¿Ha tenido alguno en el pasado? (Pregunte específicamente sobre hospitalizaciones y tratamientos con fármacos antipsicóticos en el pasado o actualmente.)

17. **Valoración global:** averigüe qué ha llevado a la persona a la entrevista y a una valoración del funcionamiento reciente, de la historia educativa, del desarrollo y social.
Incluye:
 - Preguntas relacionadas con el cribado o precibado telefónico (si se ha realizado).
 - Historia del funcionamiento laboral o académico incluyendo algunos cambios recientes. Incluye participación en programas de educación especial.
 - Historia del desarrollo.
 - Historia social y cualquier cambio reciente.

¿Cómo le han ido las cosas recientemente?

Hoja de la entrevista de contacto

Entrevistador: _____

Evalúadores presentes: _____

Otras personas presentes en la entrevista (colaterales):

Nombre	Relación con el entrevistado	Aporta información	
		Sí	No
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Otros contactos relevantes (p. ej., cuidadores, educadores, etc.):

Nombre	Relación con el entrevistado	Aporta información	
		Sí	No
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

P. SÍNTOMAS POSITIVOS

P.1. CONTENIDO DEL PENSAMIENTO INUSUAL /IDEAS DELIRANTES

Las siguientes preguntas investigan tanto el pensamiento engañoso psicótico como el pensamiento de contenido inusual no psicótico. Son evaluadas en la SOPS P1 al final de las preguntas.

S = Sí N = No NI = No información

PERPLEJIDAD Y HUMOR DELIRANTE

Preguntas

1. ¿Ha tenido alguna vez la sensación de que algo extraño o malo está ocurriendo y no puede explicar? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Ha estado alguna vez confuso sobre si percibió como real o imaginario? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿La gente de la familia o de su alrededor parecen extraños alguna vez? ¿Confusos? ¿Irreales? ¿No una parte del mundo viviente? ¿Alienados? ¿Inhumanos? ¿Diabólicos? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Su percepción del tiempo parece haber cambiado? ¿Anormalmente rápido o despacio? S N NI (anote la respuesta)
5. ¿Le ha parecido experimentar acontecimientos exactamente como ya los había experimentado antes? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

SÍNTOMAS DE PRIMER RANGO (inserción/interferencia/robo/transmisión/telepatía de pensamiento)

Preguntas

1. ¿Ha sentido que no tiene el control de sus ideas y pensamientos? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Siente que de alguna manera los pensamientos se han puesto en su cabeza o que le han sido arrebatados? ¿Alguna vez siente que alguna persona o fuerza interfiere en su pensamiento? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Alguna vez siente que sus pensamientos se propagan al exterior, por lo que la gente puede oírlos? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Piensa alguna vez que la gente puede leer su mente? S N NI (anote la respuesta)
5. ¿Piensa alguna vez que usted puede leer la mente de otras personas? S N NI (anote la respuesta)
6. ¿Alguna vez siente que la radio o la televisión se han comunicado directamente con usted? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

IDEAS SOBREVALORADAS

Preguntas

1. **¿Tiene ideologías o creencias firmes para usted como por ejemplo religión, filosofía o ideas políticas?** S N NI (anote la respuesta)
2. **¿Fantasea mucho o se encuentra a sí mismo preocupado con historias, fantasías o ideas?** ¿Alguna vez se siente confuso sobre si algo forma parte de su imaginación o si es real? S N NI (anote la respuesta)
3. **¿Le parece alguna vez que sus supersticiones afectan a su comportamiento?** S N NI (anote la respuesta)
4. **¿Hay gente que le dice que sus ideas o creencias son inusuales o extrañas?** Si es así, ¿qué son? S N NI (anote la respuesta)
5. **¿Alguna vez siente que puede predecir el futuro?** S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

OTROS PENSAMIENTOS INUSUALES/IDEAS DELIRANTES

Preguntas

1. **Ideas somáticas:** ¿Se preocupa alguna vez por si hay algo malo en su cuerpo o en su salud? S N NI (anote la respuesta)
2. **Ideas nihilistas:** ¿Ha sentido alguna vez que pueda no existir? ¿Piensa alguna vez que puede que el mundo no exista? S N NI (anote la respuesta)
3. **Ideas de culpa:** ¿Se encuentra alguna vez pensando mucho la manera de cómo ser bueno o empieza a creer que se merece ser castigado en cierta forma? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

IDEAS DE REFERENCIA NO PERSECUTORIAS

Preguntas

1. **¿Ha tenido la sensación de que generalmente es usted el centro de atención de la gente?** ¿Siente que ellos tienen intenciones malas u hostiles? S N NI (anote la respuesta)
2. **¿Ha sentido que las cosas que pasan a su alrededor tienen un significado especial sólo para usted?** S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.1. DESCRIPCIÓN

- a Perplejidad y humor delirante. Engaños mentales como por ejemplo la sensación de que algo extraño está ocurriendo, perplejidad, y confusión sobre lo que es real o imaginario. Lo familiar parece extraño, confuso, amenazador, o tiene un significado especial. Sensación de que usted mismo, otros, el mundo ha cambiado. Cambios en la percepción del tiempo. *Déjà vu*.
- b Ideas no persecutorias de referencia.
- c Fenomenología de primer rango. Acontecimientos mentales tales como inserción de pensamiento, interferencia, aislamiento, difusión, telepatía, control externo, mensajes de radio y televisión.
- d Ideas sobrevaloradas. Preocupación con ideas inusualmente valoradas (religión, mediación, filosofía, temas existenciales). Pensamiento mágico que influye en el comportamiento y es inconsistente con las normas subculturales (p. ej., supersticiones, creencia en la clarividencia, creencias religiosas no comunes).
- e Ideas inusuales sobre el cuerpo, culpa, nihilismo, envidia y religión. Los delirios podrán estar presentes pero no están bien organizados y se mantendrán de forma tenaz.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

CONTENIDO DEL PENSAMIENTO INUSUAL/IDEAS DELIRANTES

Escala de gravedad (marque una)

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
	«Trucos mentales» que son confusos. Sensación de que algo es diferente	Sobreinterés en la vida fantástica. Ideas/creencias inusualmente valoradas. Algunas supersticiones por encima de las que puedan observarse para una persona media dentro de unas normas culturales	Acontecimientos mentales no anticipados/ideas no persecutorias de referencia/trucos mentales/pensamiento mágico que no es fácilmente rechazado y puede ser irritante o preocupante. Una sensación de que estas experiencias o estas creencias convincentes nuevas están llegando a ser significativas porque ellas no se irán	Noción de que las experiencias vienen desde fuera de uno mismo o que las ideas/creencias pueden ser reales pero el escepticismo se mantiene intacto. Generalmente no afecta al funcionamiento	Creencia en la realidad de los «trucos mentales»/acontecimientos mentales/pensamiento mágico; es convincente, pero puede inducir evidencias contrarias y opiniones de otros. Puede afectar al funcionamiento	Convicción delirante (sin ninguna duda) al menos intermitentemente. Generalmente interfiere con el pensamiento, las relaciones sociales o los comportamientos

Puntuación basada en:

P.2. IDEAS PERSECUTORIAS/SUSPICACIA

Las siguientes preguntas investigan las ideas paranoides de referencia, pensamientos paranoides o suspicaces. Se evalúan en la SOPS P2 al final de las preguntas.

Preguntas

1. ¿Alguna vez siente que las personas de su alrededor están pensando sobre usted de una manera negativa? ¿Ha descubierto más tarde que esto no era verdadero o que sus sospechas eran infundadas? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Se ha encontrado alguna vez con sentimientos de desconfianza o sospecha de otra gente? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Alguna vez siente que tiene que prestar más atención a lo que está ocurriendo a su alrededor para sentirse seguro? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Se siente como si le estuvieran controlando u observando? S N NI (anote la respuesta)
5. ¿Siente que la gente pueda estar intentando hacerle daño? ¿Tiene algún presentimiento de quien puede ser? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.2. DESCRIPCIÓN

- a Ideas persecutorias de referencia.
- b Pensamiento paranoide o suspicaz.
- c Presenta una actitud encubierta o incluso abierta de desconfianza que puede reflejar convicción delirante y entrometerse en la entrevista y/o comportamiento.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

IDEAS PERSECUTORIAS/SUSPICACIA

Escala de gravedad (marque una)

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave pero no psicótico	6 Grave y psicótico
	Cautela	Dudas sobre seguridad. Hipervigilancia sin fuente clara de peligro	Nociones de que la gente es hostil, no digna de confianza, y/o fácilmente rencorosa. Sentimiento de que la hipervigilancia puede ser necesaria. Sentimiento recurrente (todavía infundado o exagerado a veces) de que la gente está pensando o diciendo cosas negativas de la persona. Puede parecer desconfiado con el entrevistador	Pensamientos claros o convencidos de ser observado o controlado. Sentimiento de que la gente intenta dañar. Desconfiado. Creencias fácilmente descartadas. La presentación puede parecer cautelosa. Reacio o irritado en respuesta al interrogatorio	Ideas poco organizadas de intenciones peligrosas u hostiles. El escepticismo y la perspicacia se pueden inducir con una prueba u opinión no confirmadas. El comportamiento está afectado en algún grado. La actitud defensiva puede interferir con la habilidad para comunicar información en la entrevista	Convicción paranoide delirante (sin ninguna duda) al menos de manera intermitente. Probabilidad de afectar el funcionamiento

Puntuación basada en:

P.3. IDEAS DE GRANDIOSIDAD

Las siguientes preguntas investigan la grandiosidad psicótica, la grandiosidad no psicótica y la elevada autoestima. Éstas se evalúan en la SOPS P3 al final de todas las preguntas.

Preguntas

1. **¿Siente que tiene dones o talentos especiales?** ¿Siente como si estuviese especialmente dotado para cierta área? ¿Habla sobre esto con otra gente? **S N NI (anote la respuesta)**
2. **¿Se ha comportado alguna vez sin tener en cuenta las consecuencias dolorosas como por ejemplo el derroche en una juerga?** **S N NI (anote la respuesta)**
3. **¿Le dice la gente alguna vez que sus metas y ambiciones son irreales?** ¿Cuáles? ¿Cómo imagina conseguirlos? **S N NI (anote la respuesta)**
4. **¿Se cree a sí mismo como un famoso o una persona particularmente importante?** **S N NI (anote la respuesta)**
5. **¿Alguna vez siente que ha sido escogido por Dios para una misión especial?** ¿Se siente como si pudiese salvar a otros? **S N NI (anote la respuesta)**

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.3. DESCRIPCIÓN

- a Opinión personal exagerada y sentido irreal de superioridad.
- b Cierta expansividad o alardes.
- c Delirios ocasionales de grandiosidad bien definidos que pueden influir en el comportamiento.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

IDEAS DE GRANDIOSIDAD

Escala de gravedad (marque una)

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave pero no psicótico	6 Grave y psicótico
	Pensamientos privados de ser generalmente superior en intelecto o talento	Pensamientos de ser particularmente talentoso, comprensión elevada o dotado en una o más áreas. Pensamientos que se mantienen mayoritariamente en privado	Nociones de ser inusualmente dotado, poderoso o especial. Puede ser expansivo. Promueve planes significativamente irrealizables, pero reorientados fácilmente	Creencias de poder, riqueza, talento o de habilidades vagamente organizadas. Metas irrealizables que pueden afectar a los planes y al funcionamiento	Creencias persistentes de tener un intelecto no natural, atractivo, poder o fama. El escepticismo sobre la creencia se puede obtener. Suele influir en el comportamiento y en las acciones	Convicción de delirios grandiosos (sin ninguna duda) al menos intermitentemente. Afecta al comportamiento y creencias

Puntuación basada en:

P.4. PERCEPCIONES ANÓMALAS/ALUCINACIONES

Las siguientes preguntas investigan sobre alucinaciones y anomalías de percepción no psicóticas. Se evalúan en la escala SOPS P4 al final de las preguntas.

ALTERACIONES DE PERCEPCIÓN, ILUSIONES, ALUCINACIONES

Pregunta

1. ¿Alguna vez siente que su mente le está gastando bromas? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para la respuesta «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

ALTERACIONES AUDITIVAS, ILUSIONES, ALUCINACIONES

Preguntas

1. ¿Siente alguna vez que sus oídos le están gastando bromas? S N NI (anote la respuesta)

2. ¿Se ha sentido más sensible a los sonidos? ¿Los sonidos le parecen diferentes (más altos o más suaves)? S N NI (anote la respuesta)

3. ¿Escucha alguna vez sonidos como por ejemplo portazos, chasquidos, silbidos, palmadas, pitidos en sus oídos? S N NI (anote la respuesta)

4. ¿Piensa alguna vez que oye sonidos y luego se da cuenta de que probablemente no hay nada allí? S N NI (anote la respuesta)

5. ¿Oye alguna vez sus propios pensamientos como si fueran hablados fuera de su cabeza? S N NI (anote la respuesta)

6. ¿Oye alguna voz que otros no pueden o no parecen oír? ¿Suena tan claramente como una voz hablando con usted como yo hago ahora? ¿Podrían ser sus propios pensamientos o es claramente una voz hablándole en alto? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

ALTERACIONES VISUALES, ILUSIONES, ALUCINACIONES

Preguntas

1. ¿Siente que sus ojos le están gastando bromas? S N NI (anote la respuesta)

2. ¿Parece tener más sensibilidad a la luz o las cosas que parecen diferentes en color, brillo o palidez, o cambiadas de alguna otra manera? S N NI (anote la respuesta)

3. ¿Ha visto alguna vez cosas inusuales como relámpagos, llamas, figuras borrosas o sombras aunque estén fuera del alcance de la vista? S N NI (anote la respuesta)

4. ¿Piensa alguna vez que ve gente, animales o cosas, pero luego se da cuenta de que puede que no estén allí realmente? S N NI (anote la respuesta)

5. ¿Ve alguna vez cosas que otros no pueden o no parecen ver? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

ALTERACIONES SOMÁTICAS, ILUSIONES, ALUCINACIONES

Preguntas

1. ¿Se ha dado cuenta de algunas sensaciones corporales inusuales como sentir un hormigueo, agarrotamiento, presión, dolores, quemaduras, frío, entumecimiento, vibraciones, electricidad, o daño? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Tiene sentimientos extraños en o por debajo de su piel? ¿Bichos trepando por su piel? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

ALTERACIONES OLFATIVAS Y GUSTATIVAS, ILUSIONES, ALUCINACIONES

Pregunta

1. ¿Huele o saborea alguna vez cosas que otra gente no percibe? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para la respuesta «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.4. DESCRIPCIÓN

- a Experiencias de percepción inusuales. Percepciones elevadas o apagadas, imágenes intensas, distorsiones sensoriales, ilusiones.
- b Seudoalucinaciones o alucinaciones que el sujeto intuye (p. ej., es consciente de su naturaleza anómala).
- c Alucinaciones francas ocasionales que pueden influir mínimamente en el pensamiento o el comportamiento.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

4.3. Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos (Structured Interview for Prodromal States, SIPS)

13

PERCEPCIONES ANÓMALAS/ALUCINACIONES					Escala de gravedad (marque una)	
0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
	Leves pero apreciables cambios en la sensibilidad de la percepción (p. ej., elevada, apagada, distorsionada, etc.)	Inesperados cambios de percepción amorfos que son incomprensibles pero no se consideran significativos	Repetidas imágenes amorfas (sombras, rastros, sonidos, etc.), ilusiones o alteraciones de percepción persistentes que pueden ser preocupantes o experimentadas como inusuales	Ilusiones recurrentes o alucinaciones momentáneas que se reconocen como si no fueran reales aunque pueden ser aterradoras o cautivadoras, y pueden afectar ligeramente al comportamiento. No es segura la fuente de las experiencias	Alucinaciones que ocasionalmente afectan al pensamiento o al comportamiento, que son experimentadas probablemente como fuera de uno mismo o reales. El escepticismo puede ser inducido	Alucinaciones recurrentes percibidas como reales y distintas de los pensamientos de la persona. Clara influencia en el pensamiento, los sentimientos y/o el comportamiento. El escepticismo no puede ser inducido
Puntuación basada en:						

P.5. COMUNICACIÓN DESORGANIZADA

Las siguientes preguntas exploran el trastorno de pensamiento y otras dificultades en el pensamiento y en el lenguaje. Son evaluados en la SOPS P5.

Nota. La base para evaluar incluye: la comunicación verbal y coherencia durante la entrevista además de los informes de los problemas de pensamiento verbalizados.

DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN

Preguntas

1. ¿La gente suele decirle que no pueden entenderle? ¿La gente suele parecer tener dificultad en comprenderle? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Es consciente de algunas dificultades para exponer su opinión, tales como encontrarse inconexo o saliéndose del tema cuando habla? S N NI (anote la respuesta)

Especificaciones: Para todas las respuestas «Sí», anote:

DESCRIPCIÓN/INICIO/DURACIÓN/FRECUENCIA

GRADO DE MALESTAR: ¿Cómo es esta experiencia para usted? (¿Le molesta?)

GRADO EN EL QUE INTERFIERE EN SU VIDA: ¿Actúa alguna vez bajo esta experiencia? ¿Hace algo diferente debido a esta experiencia?

GRADO DE CONVENCIMIENTO/SIGNIFICACIÓN: ¿Cómo explica esta experiencia? ¿Alguna vez siente que esto pudiera estar sólo en su cabeza? ¿Cree que es real?

P.5. DESCRIPCIÓN

- a Forma de hablar extraña. Vaga, excesivamente metafórica, estereotipada.
- b Forma de hablar confusa, desordenada, a carreras o retardada, usando palabras incorrectas, hablando sobre cosas irrelevantes en un contexto o saliéndose del tema.
- c La forma de hablar es circunstancial, tangencial o paralógica. Existe alguna dificultad en dirigir las frases hacia una meta.
- d Presencia de comunicación ininteligible y asociaciones laxas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

COMUNICACIÓN DESORGANIZADA

Escala de gravedad (marque una)

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave pero no psicótico	6 Grave y psicótico
	Palabra o frase repentina que no tiene sentido	Comunicaciones vagas, confusas, desordenadas, inconsistentes ocasionalmente. Puede salirse del tema brevemente	Ocasionales palabras incorrectas, temas irrelevantes. Frecuentes salidas de tema, pero responde fácilmente ante preguntas aclaratorias. Forma de hablar estereotipada o sobreelaborada	La forma de hablar es claramente circunstancial (p. ej., llegar gradualmente al tema). Alguna dificultad en dirigir las frases hacia una meta. La persona es capaz de ser redirigido a través del interrogatorio y la estructura de la conversación	Las comunicaciones son tangenciales (p. ej., no llegar nunca a la meta). Asociaciones laxas bajo presión. Puede responder con precisión a preguntas breves	La comunicación es imprecisa o irrelevante e ininteligible bajo mínima presión o cuando el contenido de la comunicación es complejo. No responde a la estructura de la conversación

Puntuación basada en:

RIESGO GENÉTICO Y DISFUNCIÓN GLOBAL

El riesgo genético supone cumplir los criterios del DSM-IV del trastorno de personalidad esquizotípica y/o tener un pariente de primer grado con un trastorno psicótico. El deterioro conlleva una pérdida del funcionamiento reflejado por un 30 % de reducción en la puntuación del GAF el último mes respecto a la puntuación de hace 12 meses.

DSM-IV – trastorno de personalidad esquizotípica

1. Un patrón de los déficit sociales e interpersonales marcado por una disconformidad aguda, y reducida capacidad de relaciones íntimas marcada también por alteraciones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento, empezando en la edad adulta temprana y **presente durante más de un año en una variedad de contextos**, como los indicados por cinco (o más) de los siguientes:

DSM-IV – criterio del trastorno de personalidad esquizotípica (evaluado basándose en las respuestas a la entrevista)	Sí	No
a. Ideas de referencia (excluyendo delirios de referencia)	☐	☐
b. Creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que es inconsistente con las normas de la subcultura (p. ej., supersticiones, creencia en la clarividencia, telepatía o «sexto sentido»; en niños y adolescentes, fantasías extrañas o preocupaciones)	☐	☐
c. Experiencias perceptivas no comunes, incluyendo delirios corporales	☐	☐
d. Pensamiento y forma de hablar extraña (p. ej., vago, metafórico, sobreelaborado, estereotipado)	☐	☐
e. Susplicia o ideación paranoide	☐	☐
f. Afecto inapropiado o embotado	☐	☐
g. Comportamiento o apariencia extraña, excéntrica o peculiar	☐	☐
h. Carencia de amigos íntimos o confidentes distintos de los parientes de primer grado	☐	☐
i. Elevada ansiedad social que no cede con la familiaridad y tiende a asociarse con temores paranoides y con opiniones negativas sobre uno mismo	☐	☐
¿Cumple el paciente los criterios para el DSM-IV trastorno de personalidad esquizotípica?	☐	☐

EVALUACIÓN ESQUIZOTÍPICA

Historia familiar de enfermedades mentales

1. ¿Quiénes son sus parientes de primer grado (p. ej., padre, hermano, hermanastro, hijo)?

Relación	Edad	Nombre	¿Historia de enfermedad mental? (S/N)

2. Para aquellos parientes de primer grado que tengan historia de enfermedades mentales

Nombre del pariente	Nombre del problema	Síntomas	Duración	Historia del tratamiento

3. ¿Tiene el paciente algún pariente de primer grado con algún trastorno psicótico (esquizofrenia, trastorno esquizofreniforme, psicosis breve, trastorno delirante, trastorno psicótico, trastorno psicoafectivo, manía psicótica, depresión psicótica)?
Sí ☐ No ☐

GAF-M: Cuando la puntuación considera el funcionamiento psicológico, social y ocupacional en un hipotético continuo de salud/enfermedad mental. No incluye el desajuste del funcionamiento debido a las limitaciones de la salud física (o medioambientales)

Sin síntomas: 100-91

Funcionamiento superior en una amplia variedad de actividades
Los problemas de la vida nunca parecen escaparse de la mano
Solicitado por otros debido a sus muchas cualidades positivas

Una persona haciéndolo excepcionalmente bien en todas las áreas de la vida = puntuando 95-100

Una persona haciéndolo excepcionalmente bien con el mínimo estrés en un área de la vida = puntuando 91-94

Síntomas ausentes o mínimos: 90-81

Síntomas mínimos o ausentes (p. ej., leve ansiedad ante un examen)
Buen funcionamiento en todas las áreas y satisfecho con la vida
Interesado e implicado en una amplia variedad de actividades
Eficaz socialmente
No más que problemas o preocupaciones cotidianas (p. ej., una discusión ocasional con miembros de la familia)

Una persona sin síntomas o problemas cotidianos = puntuando 88-90

Una persona con síntomas mínimos o problemas diarios = puntuando 84-87

Una persona con síntomas mínimos y problemas diarios = puntuando 81-83

Algunos síntomas transitorios: 80-71

Síntomas leves presentes, pero éstos son transitorios y reacciones esperadas a estresadores psicosociales (p. ej., dificultad para concentrarse después de una discusión familiar)
Ligero desajuste en el funcionamiento social, laboral o escolar (p. ej., quedarse atrás en la escuela o el trabajo)

Una persona con síntoma/s leve/s O desajuste leve en el funcionamiento social, laboral o escolar = puntuando 78-80

Una persona con desajustes leves en el funcionamiento en más de un área social, laboral o escolar = puntuando 74-77

Una persona con AMBOS síntomas leves Y un leve desajuste en el funcionamiento social, laboral y escolar = puntuando 71-73

Algunos síntomas persistentes leves: 70-61

Los síntomas leves que están presentes NO son simplemente esperadas reacciones a estresadores psicosociales (p. ej., depresión leve o rebajada y/o leve insomnio)
Alguna dificultad persistente en el funcionamiento social, ocupacional o escolar (p. ej., trauandad ocasional, robo dentro de la familia, o quedarse atrás en la escuela o el trabajo repetidas veces) pero tiene algunas relaciones interpersonales significativas

Una persona con síntomas leves persistentes O leve dificultad en el funcionamiento social, laboral o escolar = puntuando 68-70

Una persona con dificultad leve persistente en más de un área del funcionamiento social, laboral o escolar = puntuando 64-67

Una persona con AMBOS síntomas persistentes leves Y alguna dificultad en el funcionamiento social, laboral y escolar = puntuando 61-63

Síntomas moderados: 60-51

Síntomas moderados (p. ej., frecuente humor depresivo e insomnio y/o rumiaciones moderadas y obsesivas; o ataques de ansiedad ocasionales; o afecto llano y forma de hablar circunstancial; o problemas alimentarios y bajo el mínimo peso seguro sin depresión)
Moderada dificultad en el funcionamiento social, laboral o escolar (p. ej., pocos amigos o conflictos con los compañeros de trabajo)

Una persona con síntomas moderados O dificultad moderada del funcionamiento social, laboral o escolar = puntuando 58-60

Una persona con dificultad moderada en más de un área del funcionamiento social, laboral o escolar = puntuando 54-57

Una persona con AMBOS síntomas moderados Y dificultad moderada en el funcionamiento social, laboral y escolar = puntuando 51-53

Algunos síntomas graves o desajustes del funcionamiento: 50-31

Serios desajustes con el trabajo, la escuela o el trabajo doméstico si es un/a amo/a de casa (p. ej., incapacidad de mantener un trabajo o de permanecer en la escuela, o fracasar en la escuela, o ser incapaz de cuidar la familia y la casa)
Problemas frecuentes con la ley (p. ej., frecuentes robos en tiendas, arrestos) o comportamiento combativo ocasional
Serios desajustes en las relaciones con los amigos (p. ej., muy pocos o ningún amigo, o evita a los amigos que él/ella tiene)
Serios desajustes en las relaciones con la familia (p. ej., peleas frecuentes con la familia y/o descuidos con la familia o no tiene hogar)
Serios desajustes en las opiniones (incluyendo incapacidad para tomar decisiones, confusión, desorientación)
Serios desajustes en los pensamientos (incluyendo una preocupación constante con los pensamientos, imagen del cuerpo distorsionada, paranoia)
Serios desajustes con el humor (incluyendo un humor depresivo constante más incapacidad y desesperanza, o agitación, o humor frenético)
Serios desajustes a causa de la ansiedad (ataques de pánico, ansiedad arrolladora)
Otros síntomas: algunas alucinaciones, delirios o graves rituales obsesivos
Idealización suicida pasiva

Una persona con 1 área alterada = puntuando 48-50
Una persona con 2 áreas alteradas = puntuando 44-47
Una persona con 3 áreas alteradas = puntuando 41-43
Una persona con 4 áreas alteradas = puntuando 38-40
Una persona con 5 áreas alteradas = puntuando 34-37
Una persona con 6 áreas alteradas = puntuando 31-33

Incapacidad para funcionar en casi todas las áreas: 30-21

Preocupación suicida o idea suicida franca con preparación
O comportamiento considerablemente influenciado por delirios o alucinaciones
O serios desajustes en la comunicación (algunas veces incoherente, actúa de forma inapropiada, o profunda depresión estúpida)
Serios desajustes en el trabajo, la escuela o las tareas domésticas si es un/a amo/a de casa (p. ej., incapaz de mantener un trabajo o de permanecer en la escuela, o fracaso escolar, o incapaz de cuidar de su familia y de su casa)
Problemas frecuentes con la ley (p. ej., robos en tiendas frecuentes, arrestos) o comportamiento combativo ocasional
Serios desajustes en las relaciones con los amigos (p. ej., muy pocos o ningún amigo, o evita a los amigos que él/ella tiene)
Serios desajustes en las relaciones con la familia (p. ej., peleas frecuentes con la familia y/o descuidos con la familia o no tiene hogar)
Serios desajustes en las opiniones (incluyendo incapacidad para tomar decisiones, confusión, desorientación)
Serios desajustes en los pensamientos (incluyendo una preocupación constante con los pensamientos, imagen del cuerpo distorsionada, paranoia)
Serios desajustes de humor (incluyendo un humor depresivo constante más incapacidad y desesperanza, o agitación, o humor frenético)
Serios desajustes a causa de la ansiedad (ataques de pánico, ansiedad arrolladora)
Otros síntomas: algunas alucinaciones, delirios o rituales obsesivos graves
Idealización suicida pasiva

Una persona con 1 de los 3 primeros (únicamente) criterios = puntuando 21
O Una persona con 7 de los criterios combinados = puntuando 28-30
Una persona con 8-9 de los criterios combinados = puntuando 24-27
Una persona con 10 de los criterios combinados = puntuando 20-23

En algún riesgo de dañarse a uno mismo o a otros: 20-11

Intentos de suicidio sin clara expectación de muerte (p. ej., leve sobredosis o cortarse las muñecas con gente alrededor)
Algo de violencia grave o comportamientos de automutilación
Exaltación grave maníaca o agitación grave e impulsividad
Ocasionalmente fracasa para mantener el mínimo de higiene personal (p. ej., diarrea debido a laxantes, o esparcir las heces)
Admisión de urgencia/emergencia en el actual hospital psiquiátrico
En riesgo físico debido a problemas médicos (p. ej., anorexia grave o bulimia y algunos vómitos espontáneos o uso extenso de píldoras laxantes/diuréticas/dietéticas, pero sin serios problemas de corazón o de hígado o deshidratación y desorientación graves)

Una persona con 1-2 de las 6 áreas alteradas en esta categoría = puntuando 18-20
Una persona con 3-4 de las 6 áreas alteradas en esta categoría = puntuando 14-17
Una persona con 5-6 de las 6 áreas alteradas en esta categoría = puntuando 11-13

En riesgo persistente de dañarse gravemente a uno mismo o a otros: 10-1

Serios actos suicidas con clara expectación de morir (p. ej., apuñalarse, dispararse, colgarse, o serias sobredosis, con nadie presente)

Violencia grave frecuente o automutilación

Excitación maníaca extrema o agitación e impulsividad extremas (p. ej., gritos violentos y desgarrar el relleno del colchón de una cama)

Incapacidad persistente de mantener un mínimo de higiene personal

Urgencia/emergencia de admisión en el actual hospital psiquiátrico

En agudo y grave riesgo debido a problemas médicos (p. ej., anorexia grave o bulimia con problemas de corazón/hígado, o vómitos espontáneos CADA VEZ QUE la comida se digiere, o depresión grave con diabetes fuera de control)

Una persona con 1-2 de las 6 áreas alteradas en esta categoría = puntuando 8-10

Una persona con 3-4 de las 6 áreas alteradas en esta categoría = puntuando 4-7

Una persona con 5-6 de las 6 áreas alteradas en esta categoría = puntuando 1-3

Adaptado de Hall R. Valoración global del funcionamiento: Una escala modificada. *Psicosomáticos* 1995; 36: 267-275.

Puntuación actual: _____ **Puntuación más alta en el año pasado:** _____

N. SÍNTOMAS NEGATIVOS

N.1. ANHEDONÍA SOCIAL O AISLAMIENTO

Preguntas

1. ¿Generalmente prefiere estar solo/a o con otros? (Si prefiere estar solo, especifique la razón.) ¿Abulia social? ¿Se incomoda con facilidad cuando está con otra gente? ¿Ansiedad? ¿Otro? **(anote la respuesta)**
2. ¿Qué suele hacer en su tiempo libre? ¿Sería más sociable si tuviera la oportunidad? **(anote la respuesta)**
3. ¿Cada cuánto tiempo suele pasar un rato con sus amigos fuera de la escuela/trabajo? ¿Quiénes son sus tres amigos más íntimos? ¿Qué hace con ellos? **(anote la respuesta)**
4. ¿Cada cuánto tiempo suele pasar un rato con los miembros de su familia? ¿Qué hace con ellos? S N NI **(anote la respuesta)**

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N.1. DESCRIPCIÓN

- a Falta de amigos o confidentes distintos de sus parientes de primer grado.
- b Excesiva ansiedad social que no disminuye con la familiaridad y tiende a ser asociada con miedos paranoides más que con opiniones negativas sobre uno mismo.
- c Incómodo ante la presencia de otros y prefiere pasar el tiempo solo, aunque participe en actividades sociales cuando se le requiere. No inicia el contacto.
- d Acude pasivamente a muchas de las actividades sociales pero de una forma desinteresada y mecánica. Tiende a distanciarse del grupo.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ANHEDONÍA SOCIAL O AISLAMIENTO

Escala de síntomas negativos

1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
Ligeramente incómodo socialmente o ansioso, pero socialmente activo	Está incómodo fácilmente con otros. Desinteresado o ansioso en la mayor parte de las situaciones sociales, pero socialmente presente	Participa socialmente sólo de mala gana debido a la ansiedad o al desinterés. Participación social limitada	Pocos amigos de fuera del entorno familiar. Es desconfiado con otros o socialmente apático	Prefiere estar solo. Pasa la mayoría de su tiempo solo o con parientes de primer grado	No tiene amigos íntimos. Pasa su tiempo solo

Puntuación basada en:

N.2. ABULIA (APATÍA)

Preguntas

1. ¿Cree que tiene problemas para motivarse haciendo las cosas? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Está pasando un momento difícil para hacer las actividades diarias? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Cree que la gente tiene que «empujarle» para hacer sus cosas? ¿Ha dejado de hacer algo que solía hacer? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N.2. DESCRIPCIÓN

- a Alteraciones con la iniciación, persistencia y control de actividades dirigidas a un fin.
- b Pérdida de impulso constructivo.
- c Sentirse desinteresado; hacer las cosas supone más esfuerzo y/o lleva más tiempo hacerlas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ABULIA (APATÍA)

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Menos interés en las actividades diarias o metas a largo plazo, pero normalmente productivo	Interés disminuido por las actividades placenteras. Las tareas requieren más esfuerzo y llevan más tiempo, aunque se mantiene la productividad	Disminuido interés y productividad. Desajustes en el inicio de las tareas y/o persistencia. El inicio requiere algo de empuje	Evita muchas tareas diarias y/o actividades duraderas. Alguna reducción en los logros. Necesidad de empuje habitualmente	Abandona la mayoría de las actividades dirigidas a un objetivo. Reducción significativa en los logros. Necesidad de empuje todo el tiempo, aunque no tenga éxito	Abandona casi todas las actividades dirigidas a un objetivo. Empuje sin éxito

Puntuación basada en:

N.3. EXPRESIÓN EMOCIONAL DISMINUIDA

Pregunta

1. ¿Se ha dado cuenta o alguien le ha señalado que usted está menos emocional o conectado con la gente de lo que antes solía estar? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

Nota. La base para evaluar incluye: se observa afecto aplanado además de verbalizar una disminución en la expresión de las emociones.

N.3. DESCRIPCIÓN

- a Respuestas emocionales aplanadas, embotadas, reducidas, como las caracterizadas por una reducción de la expresión facial, modulación de los sentimientos (forma de hablar monótona) y de los gestos de la comunicación (apariencia apagada).
- b Falta de espontaneidad y de fluidez en la conversación. Reducción en la fluidez normal de la comunicación. La conversación muestra poca iniciativa. Las respuestas del paciente tienden a ser breves y sin adornos, requiriendo preguntas directas y mantenidas por el entrevistador.
- c Contacto pobre (*rapport*). Falta de empatía interpersonal, de franqueza en la conversación, de sentido de intimidad, de interés o de implicación con el entrevistador. Esto se evidencia por un distanciamiento interpersonal y comunicación verbal y no verbal reducida.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

EXPRESIÓN EMOCIONAL DISMINUIDA

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Respuestas emotivas ligeramente retrasadas o disminuidas	La conversación carece de vivacidad, está afectada	Mínima expresión emotiva	Dificultad para mantener el flujo y la espontaneidad de la conversación. Forma de hablar mayoritariamente monótona. Mínima empatía interpersonal. Puede que evite el contacto ocular	El inicio y mantenimiento de la conversación requiere preguntas directas y sostenidas por el entrevistador. Afecto aplanado. Carencia total de gestos	Afecto aplanado, forma de hablar monótona. Incapaz de mantenerse implicado con el entrevistador o de mantener una conversación a pesar de que el entrevistador esté muy inquisitivo

Puntuación basada en:

N.4. RESTRICCIÓN EMOCIONAL Y DEL YO

Preguntas

1. En general, ¿siente sus emociones menos intensas de lo que solía? ¿Se siente a veces insensible? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Encuentra que le es muy difícil distinguir diferentes emociones/sentimientos? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Se siente emocionalmente aplanado? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Siente alguna vez que está perdiendo el sentido de quién es usted? S N NI (anote la respuesta)
5. ¿Se siente desconectado de usted mismo o de su vida? ¿Como si fuera un espectador de su propia vida? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N.4. DESCRIPCIÓN

- a Experiencias emotivas y sentimientos menos reconocibles, genuinos, apropiados.
- b Sensación de distancia cuando habla con otros, ya no siente simpatía por otros.
- c Las emociones desaparecen, dificultad para sentir alegría o tristeza.
- d Sensación de no tener sentimientos: anhedonia, abulia, pérdida de interés, aburrimiento.
- e Se siente profundamente cambiado, irreal o extraño.
- f Se siente despersonalizado, distanciado de sí mismo.
- g Pérdida del sentido de uno mismo (desconectado).

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

RESTRICCIÓN EMOCIONAL Y DEL YO

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Se siente distante de otros. Sentimientos cotidianos apagados. Falta de emociones fuertes	Carece de emociones fuertes o de sentimientos definidos claramente (feliz, triste, enfadado, culpable, etc.)	Parece como si las emociones estuvieran desapareciendo, atenuadas o menos diferenciadas	Sensación de agotamiento, de aplanamiento o de tensión aversiva indiferenciada	Siente pérdida del sentido de sí mismo. Se siente despersonalizado, irreal o extraño. Puede sentirse desconectado de su cuerpo, del mundo, del tiempo. No tiene sentimientos la mayoría del tiempo	Se siente profundamente cambiado y posiblemente alienado de sí mismo. No tiene sentimientos

Puntuación basada en:

N.5. PENSAMIENTO EMPOBRECIDO

DIFICULTADES DE COMPRENSIÓN

Preguntas

1. ¿Encuentra algunas veces difícil comprender lo que la gente está intentando decirle porque no entiende qué quieren decir?
S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Utiliza la gente cada vez más palabras que usted no entiende? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

Preguntas abstractas:

1. Similitudes— ¿En qué se parecen las siguientes preguntas? (elija una)

- a ¿Una pelota y una naranja? _____
- b ¿Una manzana y un plátano? _____
- c ¿Una pintura y un poema? _____
- d ¿El aire y el agua? _____

2. Proverbios— «¿Qué significa este dicho?»

- a No juzgues un libro por su portada _____
- b No cuentes tus pollitos antes de que salgan del cascarón _____

N.5. DESCRIPCIÓN

- a Incapaz de darle un sentido a frases familiares o de comprender lo esencial de una conversación o de seguir una charla cotidiana.
- b Contenido verbal estereotipado. Fluidez, espontaneidad y flexibilidad de pensamiento, disminuidas como se evidencia en el contenido del pensamiento repetido o simple. Algo de rigidez en sus actitudes o creencias. No considera posiciones alternativas o tiene dificultad para cambiar de una idea a otra.
- c Estructura simple de palabras y de oraciones; escasez de oraciones subordinadas o de calificativos (adjetivos/adverbios).
- d Dificultad en el pensamiento abstracto. Desajustes en el uso del modo de pensamiento abstracto-simbólico más allá del pensamiento concreto o egocéntrico, como se evidencia en la dificultad de clasificación, en la formación de generalizaciones y en el procedimiento de tareas para resolver problemas; a menudo utiliza un modo concreto.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PENSAMIENTO EMPOBRECIDO

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Algunas dificultades en la conversación	Problemas para comprender matices de la conversación. Disminución en dar y recibir conversación	Interpreta correctamente la mayoría de las similitudes y proverbios. Usa pocos calificativos (adjetivos y adverbios). Pueden perderse algunos comentarios abstractos	A ratos pierde la esencia de la conversación razonablemente no complicada. El contenido verbal puede ser repetitivo y perseverante. Usa estructuras simples en palabras y oraciones sin muchos calificativos. Se pierde o interpreta muchas similitudes y proverbios concretamente	Capaz de seguir y responder a afirmaciones simples y preguntas, pero tiene dificultad para articular pensamientos y experiencias independientemente. Contenido verbal limitado y estereotipado. Expresión verbal limitada a oraciones simples, breves. Puede no ser capaz de interpretar la mayoría de las similitudes y proverbios	Incapaz de seguir cualquier conversación a ratos, sin importar cómo son de simples. Contenido verbal y expresión mayoritariamente limitada a palabras sueltas y repuestas de sí/no

Puntuación basada en:

N. 6. DETERIORO EN EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL

Preguntas

1. ¿Su trabajo le requiere más esfuerzo que antes? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Está teniendo dificultad para acabar el trabajo? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Ha estado funcionando peor en la escuela o en el trabajo? S N NI ¿Ha estado puesto a prueba o cuestionado en su trabajo o ha sido advertido de despido debido a su mal funcionamiento? ¿Está perdiendo algunas clases o considerando dejar la escuela? ¿Ha sido alguna vez «invitado a abandonar» su trabajo, o ha tenido problema en mantener su trabajo? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Ha tenido dificultades con sus amigos? ¿Familia? ¿Colegas? ¿Ha tenido más discrepancias? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

N. 6. DESCRIPCIÓN

- a Dificultad para realizar las funciones de los roles (p. ej., trabajador, estudiante, amo/a de casa) que previamente realizaba sin problemas.
- b Tiene dificultad para las relaciones productivas, dirigidas a un fin, con los colegas, en el trabajo o en la escuela.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

DETERIORO EN EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL

Escala de síntomas negativos

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Requiere de más esfuerzo y concentración para mantener el mismo nivel de actuación en el trabajo, en la escuela y en las relaciones	Dificultad de funcionamiento en el trabajo, en la escuela y en las relaciones que es evidente para otros	Problemas determinados para realizar las tareas del trabajo o bajan un grado en las calificaciones de los estudios. Interacción social limitada	Suspense en uno o más cursos. Despido laboral o estar a prueba en el trabajo. Más conflictos o menos contacto con amigos, familia o colegas	Suspense, riesgo de fracaso escolar, u otra interferencia significativa completando los requerimientos. Ausencia problemática en el trabajo. Dificultades significantes con las relaciones	Fracaso o aislamiento escolar, ha abandonado el empleo o fue despedido. Incapaz de mantener relaciones con otros

Puntuación basada en:

D. SÍNTOMAS DE DESORGANIZACIÓN

D. 1. APARIENCIA O COMPORTAMIENTO RARO

Preguntas

1. ¿Qué tipo de actividades le gustan? (anote la respuesta)
2. ¿Tiene alguna afición, intereses especiales o colecciones? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Dice alguna vez la gente que sus intereses son inusuales o que usted es excéntrico? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

Nota. La base para evaluar incluye: observaciones del entrevistador de apariencia inusual o excéntrica además de informes de comportamiento o apariencia excéntrica, inusual o extraña.

D. 1. DESCRIPCIÓN

- a Comportamiento o apariencia rara, excéntrica, peculiar, desorganizada o extraña.
- b Parece preocupado por los estímulos internos (alucinaciones...).
- c Afecto inapropiado.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

APARIENCIA O COMPORTAMIENTO RARO

Escala de síntomas de desorganización

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Apariencia o comportamiento cuestionablemente inusual	Comportamiento o apariencia que aparece mínimamente inusual o extraño	Comportamiento, intereses, apariencia, aficiones o preocupaciones extrañas, inusuales, que son consideradas fuera de las normas culturales. Puede exhibir comportamiento inapropiado	Comportamiento o apariencia que no es convencional para la mayoría de los patrones. Puede aparecer distraído por estímulos aparentes internos. Puede parecer desconectado o desimplicado	Comportamiento o apariencia altamente no convencional, extraña. Puede parecer preocupado por estímulos aparentes internos a ratos. Puede dar respuestas no contextuales, o exhibir afecto inapropiado	Apariencia o conducta ostensiblemente extraña (p. ej., coleccionar basura, hablar solo en público). Desconexión de afecto y habla

Puntuación basada en:

D. 2. PENSAMIENTO EXTRAÑO

Pregunta

1. ¿La gente dice que sus ideas son inusuales o que el modo en que piensa es raro o ilógico? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

Nota. La base para evaluar incluye: observaciones de pensamiento extraño además de informes de pensamiento inusual.

D. 2. DESCRIPCIÓN

- a Pensamiento caracterizado por ideas extrañas, fantásticas o extravagantes que están distorsionadas, son ilógicas o patentemente absurdas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PENSAMIENTO EXTRAÑO

Escala de síntomas de desorganización

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Ideas no frecuentes, peculiares, que son fácilmente abandonadas	Ideas inusuales ocasionales, pensamiento ilógico o distorsionado	Ideas inusuales persistentes, pensamientos ilógicos o distorsionados que se mantienen como una creencia o sistema filosófico dentro de la esfera de la variación subcultural	Pensamiento persistente inusual o ilógico que se acepta pero que viola el límite de la mayoría de los pensamientos filosóficos o religiosos	Construcción ilógica de ideas extrañas que son difíciles de seguir	Preocupado con pensamientos que son fantásticos, patentemente absurdos, fragmentados, e imposibles de seguir

Puntuación basada en:

D. 3. PROBLEMAS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Preguntas

1. ¿Ha tenido dificultad para concentrarse o ser capaz de prestar atención en una tarea? ¿Leer? ¿Escuchar? ¿Está empeorando? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Se distrae con facilidad? ¿Confuso fácilmente por ruidos, o por otra gente que hable? ¿Está empeorando? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Ha tenido problema para recordar cosas? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

D. 3. DESCRIPCIÓN

- a Dificultades para mantenerse atento, manifestado por una concentración escasa, distracción debida a estímulos internos y externos.
- b Dificultad en utilizar, cambiar o mantener la concentración en nuevos estímulos.
- c Problemas con la memoria a corto plazo, incluyendo mantener la conversación en la memoria.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

PROBLEMAS DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

Escala de síntomas de desorganización

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Lapsus ocasionales de concentración bajo presión	Pérdida de atención ocasional en las tareas o conversaciones cotidianas	Problemas persistentes para mantener la atención y la concentración. Dificultad para mantener conversaciones	Generalmente distraído y pierde el hilo de la conversación con regularidad	Puede mantener la atención y permanecer concentrado sólo con la ayuda o el soporte exterior	Incapaz de mantener la atención incluso con refocalización exterior

Puntuación basada en:

D.4. DETERIORO DE LA HIGIENE PERSONAL/HABILIDADES SOCIALES

Preguntas

1. ¿Está menos interesado en mantenerse limpio o vestirse bien? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Con qué frecuencia se ducha? (anote la respuesta)
3. ¿Cuándo fue la última vez que fue a comprar ropa nueva? ¿Qué compró? (anote la respuesta)
4. ¿Piensa que otros le considerarían «en las nubes»? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

D.4. DESCRIPCIÓN

- a Deterioro del arreglo e higiene personal. Falta de autocuidado.
- b Descortesía social. Aparta la mirada, aparece desimplicado o desconectado.
- c «Despistado» («en la Luna»), «ajeno al tema». Termina las conversaciones abruptamente, sin razones aparentes.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ETERIORO DE LA HIGIENE PERSONAL/HABILIDADES SOCIALES

Escala de síntomas de desorganización

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Menos atención a la higiene personal pero todavía se interesa por las apariencias	Menos atención a la higiene personal y menos interés por la apariencia, pero todavía dentro de unos límites de convención y/o subcultura	Indiferencia ocasional hacia las convenciones y normas subculturales del vestir y de las pautas sociales	Falta de cumplimiento persistente de las normas subculturales o sociales de higiene. Ligeramente «despistado» o no atento socialmente	Fracaso e inestabilidad en las interacciones. Ya no se asea regularmente	Arreglado pobremente y parece no importarle o ni siquiera darse cuenta. Sin aseo y puede presentar mal olor. Falta de atención y ausencia de respuesta a las pautas sociales incluso cuando se afrontan

Puntuación basada en:

G. SÍNTOMAS GENERALES

G. 1. ALTERACIONES DEL SUEÑO

Preguntas

1. **¿Cómo ha dormido recientemente?** ¿Qué tipo de dificultades ha tenido para dormir? (incluya para irse a la cama, para dormir y despertarse, horas de sueño en un período de 24 horas, dificultad para quedarse dormido, despertarse pronto, inversión del ciclo sueño/vigilia) **(anote la respuesta)**
2. **¿Se encuentra cansado durante el día?** ¿Le está haciendo difícil pasar el día su problema para dormir? ¿Tiene problemas para levantarse? **S N NI (anote la respuesta)**

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G. 1. DESCRIPCIÓN

- a Tiene dificultad para dormir.
- b Despertarse más temprano de lo deseado y no ser capaz de volverse a dormir.
- c Fatiga y sueño durante el día.
- d Inversión del ciclo sueño/vigilia (día/noche).
- e Hipersomnia.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ALTERACIONES DEL SUEÑO

Escala de síntomas generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Duerme más inquieto de lo habitual	Ligera dificultad para dormirse o para volver a dormirse en caso de despertarse. Duerme más de lo habitual	Fatiga durante el día resultante de la dificultad para dormirse por la noche o de despertarse temprano. Pasa la mayor parte del día dormido	El patrón de sueño ha sido significativamente alterado e interfiere con otros aspectos del funcionamiento (p. ej., problemas para levantarse para ir a la escuela o al trabajo). Dificultad al levantarse para acudir a compromisos	Dificultad significativa para dormirse o despertarse temprano la mayoría de las noches. Puede tener inversión del ciclo sueño/vigilia. Generalmente no acude nunca a actividades programadas	Incapaz de dormir nada durante más de 48 horas

Puntuación basada en:

G.2. DISFORIA

Preguntas

1. ¿Cómo ha sido su humor recientemente? (anote la respuesta)
2. ¿Generalmente se siente infeliz durante algún período de tiempo? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Ha estado deprimido alguna vez? ¿Se encuentra que llora mucho? ¿Se siente triste/mal/inútil/desesperado? ¿Ha afectado su humor a su apetito? ¿A su sueño? ¿A su capacidad para trabajar? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Ha tenido pensamientos de dañarse a sí mismo o de acabar con su vida? ¿Ha intentado suicidarse alguna vez? S N NI (anote la respuesta)
5. ¿Ha tenido pensamientos de dañar a alguien? S N NI (anote la respuesta)
6. ¿Encuentra que se siente irritable la mayoría del tiempo? ¿Se enfada con frecuencia? ¿Suele golpear a alguien o a algo? S N NI (anote la respuesta)
7. ¿Se ha sentido más nervioso, ansioso últimamente? ¿Dificultad para relajarse? ¿Se siente de esa manera durante un largo período de tiempo? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G.2. DESCRIPCIÓN

- a Interés disminuido en actividades placenteras.
- b Problemas de sueño.
- c Apetito pobre o aumentado.
- d Sentimientos de pérdida de energía
- e Dificultad para concentrarse.
- f Pensamientos suicidas.
- g Sentirse inútil y/o culpable.

TAMBIÉN

- a Ansiedad, pánico, múltiples miedos, fobias.
- b Irritabilidad, hostilidad, ira.
- c Inquietud, agitación, tensión.
- d Humor inestable.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

DISFORIA

Escala de síntomas generales

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Sentirse más a menudo «bajo» o «al límite»	Ocasionales períodos inestables y/o impredecibles de sentimientos «grises», tristes o malos, que pueden ser una mezcla de depresión, irritabilidad o ansiedad	Sentimientos de decaimiento o de otras ansiedades o descontentos persistentes	Frecuentes períodos de tristeza, irritabilidad o depresión	Mezclas persistentes desagradables de depresión, irritabilidad o ansiedad. Comportamientos de evitación tales como dormir o el uso de sustancias	Mezclas dolorosamente desagradables de depresión, irritabilidad o ansiedad que desencadenan comportamientos altamente destructivos tales como suicidio o automutilación

Puntuación basada en:

G.3. ALTERACIONES MOTORAS

Pregunta

1. ¿Ha notado algún cambio en la manera de moverse? Por ejemplo, ¿alguna torpeza o falta de coordinación que haya hecho difícil su actuación en actividades que solía ser capaz de hacer? **S N NI (anote la respuesta)**

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G.3. DESCRIPCIÓN

- a Se informa o se observa torpeza, falta de coordinación, dificultad para actuar en actividades que en el pasado eran realizadas sin problemas.
- b Desarrollo de nuevos movimientos tales como hábito nervioso, estereotipos, maneras características de hacer algo, posturas, o copiar los movimientos de otras personas (ecopraxia).
- c Bloqueos motores (catatonía).
- d Pérdida de habilidades motoras básicas.
- e Rituales motores compulsivos.
- f Movimientos discinéticos de cabeza, cara y extremidades.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

ALTERACIONES MOTORAS

Escala de síntomas generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
	Torpeza	Se informa o se observa torpe	Coordinación pobre. Dificultad en realizar buenos movimientos motores	Movimientos estereotipados, a menudo inapropiados	Hábitos nerviosos, tics, muecas. Posturas. Rituales motores compulsivos	Pérdida de habilidades motoras básicas. Bloqueos motores. Ecopraxia. Discinesia

Puntuación basada en:

G.4. TOLERANCIA DISMINUIDA AL ESTRÉS NORMAL

Preguntas

1. ¿Se siente más cansado o estresado al final de un día normal? S N NI (anote la respuesta)
2. ¿Se ha estado sintiendo más desconcertado por cosas inesperadas que ocurrieron durante el día? S N NI (anote la respuesta)
3. ¿Esas cosas le están haciendo más difícil afrontar el día? S N NI (anote la respuesta)
4. ¿Encuentra que se siente amenazado, evitando o completamente saturado por algunas de sus actividades diarias? ¿Siente que son muy arduas o pesadas? S N NI (anote la respuesta)
5. ¿Encuentra que está demasiado estresado, desorganizado, o falta de energía y motivación para incluso afrontar las actividades diarias? S N NI (anote la respuesta)

PARA TODAS LAS RESPUESTAS ANOTE: DESCRIPCIÓN, INICIO, DURACIÓN Y CAMBIO CON EL TIEMPO

G.4. DESCRIPCIÓN

- a Evita o se agota con situaciones estresantes que eran previamente afrontadas con facilidad.
- b Síntomas marcados de ansiedad o de evitación a respuestas para los estresores diarios.
- c Afectado crecientemente por experiencias que eran fácilmente controladas en el pasado. Más dificultad para habituarse a las cosas.

Las casillas están destinadas a proporcionar directrices y ejemplos de signos para cada síntoma observado. No es necesario que se cumplan todos los criterios en cada casilla para conseguir un valor concreto. Las bases para las puntuaciones incluyen observaciones e informes.

TOLERANCIA DISMINUIDA AL ESTRÉS NORMAL

Escala de síntomas generales

0 Ausente	1 Presencia dudosa	2 Leve	3 Moderado	4 Moderadamente grave	5 Grave	6 Extremo
	Más cansado o estresado al final de un día normal	El estrés diario trae síntomas de ansiedad más allá de lo que pudiera ser esperado	Desestabilizado por acontecimientos inesperados en un día normal	«Amenazado» por experiencias diarias que eran fácilmente controladas en el pasado	Evita o está saturado por situaciones que previamente eran afrontadas con facilidad	Desorganización, pánico, abulia o aislamiento en respuesta al estrés diario

Puntuación basada en:

RESUMEN DE LOS DATOS SIPS

Escala de síntomas positivos

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave pero no psicótico</i>	6 <i>Grave y psicótico</i>
---------------------	----------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------------

Síntomas positivos

	0	1	2	3	4	5	6	Totales
P.1. Contenido del pensamiento inusual/ideas delirantes	0	1	2	3	4	5	6	
P.2. Ideas persecutorias/susplicia	0	1	2	3	4	5	6	
P.3. Ideas de grandiosidad	0	1	2	3	4	5	6	
P.4. Percepciones anómalas/alucinaciones	0	1	2	3	4	5	6	
P.5. Comunicación desorganizada	0	1	2	3	4	5	6	

Escala de síntomas negativos, de desorganización, generales

0 <i>Ausente</i>	1 <i>Presencia dudosa</i>	2 <i>Leve</i>	3 <i>Moderado</i>	4 <i>Moderadamente grave</i>	5 <i>Grave</i>	6 <i>Extremo</i>
---------------------	----------------------------------	------------------	----------------------	-------------------------------------	-------------------	---------------------

Síntomas negativos

	0	1	2	3	4	5	6	Totales
N.1. Anhedonía social o aislamiento	0	1	2	3	4	5	6	
N.2. Abulia (apatía)	0	1	2	3	4	5	6	
N.3. Expresión emocional disminuida	0	1	2	3	4	5	6	
N.4. Restricción emocional y del yo	0	1	2	3	4	5	6	
N.5. Pensamiento empobrecido (comprensión y abstracción)	0	1	2	3	4	5	6	
N.6. Deterioro en el funcionamiento global	0	1	2	3	4	5	6	

Síntomas de desorganización

D.1. Apariencia o comportamiento raro	0	1	2	3	4	5	6
D.2. Pensamiento extraño	0	1	2	3	4	5	6
D.3. Problemas de atención y concentración	0	1	2	3	4	5	6
D.4. Deterioro de la higiene personal/habilidades sociales	0	1	2	3	4	5	6

Síntomas generales

G.1. Alteraciones del sueño	0	1	2	3	4	5	6
G.2. Disforia	0	1	2	3	4	5	6
G.3. Alteraciones motoras	0	1	2	3	4	5	6
G.4. Tolerancia disminuida al estrés normal	0	1	2	3	4	5	6

Trastorno esquizotípico de la personalidad Sí ☐ No ☐

Historia familiar de enfermedad psicótica Sí ☐ No ☐

GAF Actual _____ Más alta en el pasado año _____

SUMARIO DE CRITERIOS DE LA SIPS

I. Excluye psicosis del pasado o presentes: presencia de síndrome psicótico (PSP 3.0)

<i>Síndrome psicótico</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
A. ¿Está puntuada con un 6 alguna de las escalas del SOPS P1-P5?	☐	☐
B. Si es así para A, ¿han estado presentes los síntomas <i>sólo</i> en los tres meses anteriores?	☐	☐
C. Si es así para A y B, ¿hay algún síntoma grave de desorganización o peligro...?	☐	☐
D. Si es así para A y B, ¿han ocurrido los síntomas durante al menos una hora al día con una frecuencia media de cuatro veces a la semana durante un mes?	☐	☐

Si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. Si A es sí y B es no, el paciente cumple criterios de psicosis pasadas.
2. Si A, B y C son todas sí, el paciente cumple criterios de psicosis actual.
3. Si A, B y D son todas sí, el paciente cumple criterios de psicosis actual.

II. Incluye el síndrome prodrómico: criterios de síndromes prodrómicos (CSP 3.0)

<i>A. Síndrome prodrómico psicótico breve intermitente</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
1. ¿Está puntuada con un 6 alguna de las escalas del SOPS P1-P5?	☐	☐
2. Si es así para 1, ¿han comenzado los síntomas en los pasados tres meses?	☐	☐
3. Si es así para 1 y 2, ¿están los síntomas presentes actualmente durante al menos varios minutos al día con una frecuencia de al menos una vez al mes?	☐	☐

Si 1-3 son sí, anote la fecha cuando cumple el criterio por primera vez (día/mes/año): _____

<i>B. Síndrome prodrómico positivo atenuado</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
1. ¿Está puntuada de 3 a 5 alguna de las escalas del SOPS P1-P5?	☐	☐
2. Si es así en 1, ¿han empezado alguno de estos síntomas en el año pasado o hay una o varias de las puntuaciones de cualquier escala que haya superado su intensidad con respecto a hace 12 meses?	☐	☐
3. Si es así en 1 y 2, ¿han ocurrido los síntomas en una media de frecuencia de al menos una vez por semana en el mes pasado?	☐	☐

Si 1-3 son sí, anote la fecha en que aparecieron los criterios (día/mes/año): _____

<i>C. Síndrome prodrómico con riesgo genético y disfunción global</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>
1. El paciente cumple criterios del trastorno esquizotípico de la personalidad	☐	☐
2. El paciente tiene un pariente de primer grado con un trastorno psicótico	☐	☐
3. El paciente está experimentando al menos un 30 % de disminución en la puntuación GAF sobre el mes pasado en comparación con hace 12 meses	☐	☐

Si se cumplen alguna de las siguientes condiciones:

1. 1 y 3.
2. 2 y 3.
3. 1 y 2 y 3.

Anote la fecha en que cumple los criterios por primera vez (día/mes/año): _____

Por favor, marque sí o no.

- ☐ No ☐ Sí **Síndrome psicótico**
☐ No ☐ Sí **Síndrome prodrómico psicótico breve intermitente**
☐ No ☐ Sí **Síndrome prodrómico positivo atenuado**
☐ No ☐ Sí **Síndrome prodrómico con riesgo genético y disfunción global**